手が震える…
これってパーキンソン病？

脳神経内科医が教える
振戦の見分け方と受診の目安

その症状、大丈夫？ #01

医知創造ラボ ～脳神経内科医がAIで紡ぐ最新医療情報～

こんな経験、ありませんか？

- ☕ コーヒーカップを持つと手が震える
- ✍ 字を書くとき、線がガタガタになる
- 🍽 箸で食べ物をつまみにくい
- 📱 スマホを持つ手が小刻みに揺れる

手の震え（振戦）とは？

振戦（しんせん）

自分の意思とは関係なく、筋肉が
規則的・リズミカルに収縮する運動

40歳以上の約4%

に何らかの振戦がある

→ 珍しい症状ではない！

原因を見分けるカギ

「いつ、どんなときに
震えるか」を観察する

振戦の3つのタイプ — いつ震えるかで分類

安静時振戦

いつ？

じっとしている時

主な原因

パーキンソン病

姿勢時・動作時振戦

いつ？

手を伸ばした時
物を持つ時

主な原因

本態性振戦（最多）
甲状腺・薬剤性

企図振戦

いつ？

目標に手を
近づける時

主な原因

小脳疾患

安静時振戦 — パーキンソン病の特徴

じっとしている時に震え、手を動かすと一時的に止まる

- 「丸薬を丸める」ような親指と人差し指の動き（pill-rolling）
- 片側から始まることが多い
- 動作が遅くなる・体が硬くなる・歩幅が狭くなる等を伴う
- 50〜70代に多い

姿勢時・動作時振戦 — 本態性振戦（最多！）

手を伸ばした時・物を持つ時に震える ＝ 振戦で最も多い原因

- 命に関わらないが、生活の質を下げることがある
- 家族にも同じ症状がある人が約半数
- お酒を飲むと一時的に軽くなるのが特徴
- 10〜20代で発症することもある
- 薬（プロプラノロール等）で症状を軽減できる

パーキンソン病 vs 本態性振戦

比べるポイント	パーキンソン病	本態性振戦
震えるタイミング	安静時	動作時・姿勢時
震え以外の症状	あり（動作緩慢等）	基本的にない
頭の震え	まれ	よくある
家族歴	まれ	約50%にあり
飲酒の影響	変わらない	一時的に軽減
食事のとき	ゆっくりだが可能	箸が持ちにくい

その他の原因 — ストレス・薬・甲状腺

緊張・ストレス

交感神経の活性化。
誰にでも起こる生理的反応

薬の副作用

喘息薬・抗うつ薬・
リチウム・抗てんかん薬等

甲状腺の病気

バセドウ病など。動悸・
発汗・体重減少を伴う

カフェイン過剰

コーヒー等の飲みすぎ。
減量で改善

⚠ こんな震えはすぐ受診 — 危険なサイン5つ

1. 急に片側だけ震え始めた
2. ろれつが回らない・力が入らないを伴う
3. 日常生活に支障がある（食事・字が書けない）
4. 震え以外の症状が増えている（歩きにくい等）
5. 数週間で明らかに悪化している

受診の目安 — 緊急度3段階

● すぐ受診（救急）

突然の震え＋片側の脱力・
ろれつ困難・意識の変化

→ 119番で救急搬送

● 早めに受診

震えが持続、生活に支障、
他の症状もある

→ 脳神経内科を予約

● 様子見OK

緊張時だけ、すぐ治まる、
生活に支障なし

→ 生活習慣見直し

自分でできるセルフチェック

コップテスト
水を入れたコップを持ち、口に運ぶ
→ 震えるなら姿勢時・動作時振戦

手を伸ばすテスト
両手を前に10秒間キープ
→ 指先の震えを確認

渦巻き描画テスト
紙に渦巻きを描く
→ 線のガタつきが振戦の指標に

※ セルフチェックはあくまで目安です。気になる場合は医師にご相談ください。

まとめ — 手の震えで覚えておきたい3つ

1 「いつ震えるか」が原因を見分けるカギ

安静時 → パーキンソン病の可能性
動作時 → 本態性振戦が多い

2 大半は命に関わらない

最多は本態性振戦やストレス
ただし放置すると生活の質が低下

3 迷ったら脳神経内科へ

振戦の原因を見分ける
プロフェッショナルです

ご視聴ありがとうございました

チャンネル登録・高評価よろしくお願いします！

🔗 ブログ記事で詳しく読む（概要欄にリンク）

🔍 手のふるえセルフチェックツール（概要欄にリンク）

📺 次回：「ろれつが回りにくい」は脳のSOS？

医知創造ラボ